

SUITE DE COUCHE NORMALE ET PATHOLOGIQUE

OBJECTIFS:

- Connaître les différentes modifications physiologiques dans le post-partum
- Conduire l'examen clinique du post-partum
- Diagnostiquer les principales complications maternelles des suites de couches

I. INTRODUCTION

- Les suites de couches sont « la période qui s'étend de l'accouchement jusqu' à la première menstruation normale, ou retour de couches ».
- Correspond à un retour de l'anatomie et de la physiologie d'avant la grossesse,
- 6 semaines en moyenne   

II. SUITE DE COUCHE NORMALE

Modifications anatomiques:

• Utérus:

× Corps utérin:

-Après l'accouchement, le fond utérin est juste sous l'ombilic

-Tranchées utérines++ 

-La fin de 1ère semaine, le fond utérin est à mi-distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne

-La fin de 2ème semaine, le fond utérin est sous la symphyse pubienne

× Col utérin:

-Vers la fin de la 1ère semaine, le col reprend sa forme et sa consistance ferme mais reste souvent perméable

-A la fin de la 2ème semaine : l'orifice interne du col redevient imperméable

× Muqueuse utérine:

-Phase de Régression jusqu'au 5ème jour: La caduque régresse, la cavité utérine se recouvre de fibrine

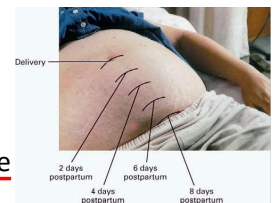
-Phase de Cicatrisation, du 6ème au 25ème jour: L'épithélium de l'endomètre se reconstitue

-Phase de Régénération, du 25ème au 45ème jour: Sous l'influence des estrogènes l'endomètre prolifère

-Phase de Reprise du cycle menstruel 45ème jour: Retour de couches

× Vagin: Reprend sa trophicité normale à partir du 25ème jour

× Vulve et Périnée: Reprennent progressivement la tonicité



• Lochies :

× Écoulement d'origine utérine, mélange de sang, de débris de caduques, et de sécrétions utérines:

- Sang non coagulé: 2- 3 jours

- Séro-sanglantes jusqu'au 8ème jour

- Séreuses jusqu'au 15ème jour

• Sein:

× Pendant la grossesse:

-Les sécrétions placentaires d'œstrogène et de progestérone entraînent une:

- Hypertrophie mammaire
- Inhibition de la synthèse des constituants du lait (inhibition de la sécrétion de prolactine)

× Après l'accouchement:

-La chute brutale des taux d'œstrogène et de progestérone stimule la sécrétion de prolactine et l'installation de la lactation en 2 ou 3 jours : c'est la montée laiteuse

• Phénomènes généraux:

-Température: Légère élévation 48 heures 

-Troubles urinaires: Parfois une rétention d'urine régressant souvent spontanément, Incontinence urinaire d'effort (IUE) fréquente

-Troubles digestives : Constipation, souvent une poussée hémorroïdaire

Modifications hormonales:

Œstrogènes: S'effondrent avec reprise de la sécrétion à partir du 25ème jr.

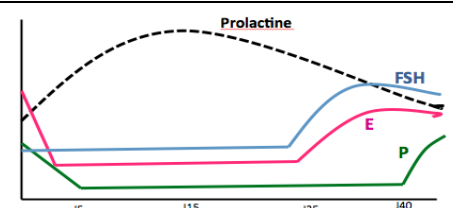
Et à partir de 35-45ème jr si allaitement

Progestérone: Baisse les 10 premiers jours puis reprise après le 40ème jour

FSH: Reprise à partir du 25ème jour

LH : Pic ovulatoire après le 40ème jour

Prolactine: Augmentation rapide, diminution à partir du 15ème jour



III. EXAMEN DES SUITES DE COUCHES

Les signes généraux :

- Pouls
- TA
- Température

L'involution du globe utérin :

- Hauteur et consistance de l'utérus
- Les lochies : Abondance, Aspect, Odeur

Les membres inférieurs

- Recherche de signes de phlébite:
 - ✗ Pouls grimpants de Mahler
 - ✗ Asymétrie des mollets
 - ✗ Douleurs à la dorsi-flexion du pied (Sx Homans)
 - ✗ Douleurs, chaleurs

L'appareil urinaire:

- Signes fonctionnels: rétention, dysurie, pollakiurie
- Aspect des urines

L'appareil digestif: Constipation

Examen des seins:

- Crevasse
- Montée laiteuse

Le « Baby Blues »:

- Syndrome dépressif mineur qui apparaît vers J3
- Lié à la fatigue, aux « petits ennuis » et aux problèmes affectifs
- Faire attention à ce syndrome et informer l'entourage: Écouter. Rassurer. Réconforter

CONTRACEPTION POST PARTUM:

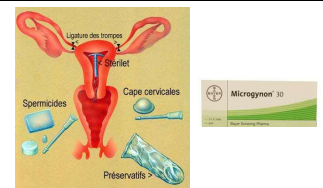
Micro progestatif : Gold standard

- Si allaitement: Contraception: micro progestatifs à partir de la 6ème semaine

- En absence d'allaitement: Contraception: micro progestatifs à partir de la 3ème semaine

Informations claires: Prise régulière. Spotting

Autres moyens possibles : Préservatifs. Spermicides. DIU post-partum lointain

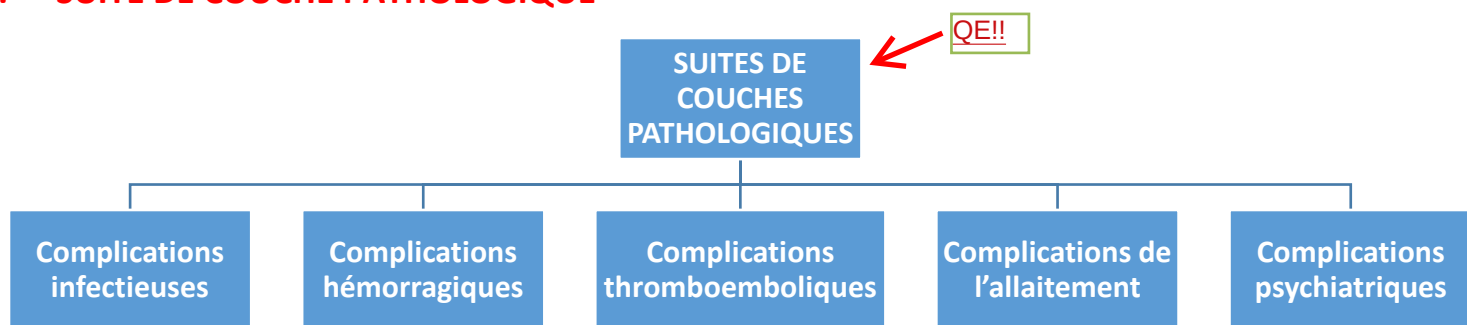


IV. CONSULTATION DU POSTPARTUM TARDIVE

➤ 6-8 ème semaines:

- Examen général
- Examen Abdominal: Involution utérine, cicatrice de la césarienne
- Examen gynécologique:
 - ✗ Béance vulvaire, colpocèle et cystocèle
 - ✗ Continence anale, urinaire (informer sur l'intérêt de la rééducation périnéale)
 - ✗ Vérifier la qualité des cicatrices (épisiotomie, cicatrice de la césarienne)
- Proposer le FCV
- Discuter: La contraception et la programmation de la grossesse ultérieure

V. SUITE DE COUCHE PATHOLOGIQUE



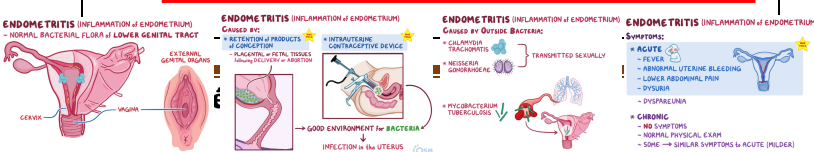
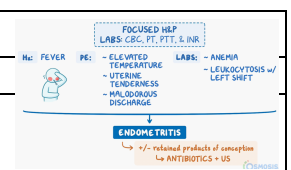
1. COMPLICATIONS INFECTIEUSES

A. L'ENDOMÉTRITE DU POST-PARTUM:

❖ Clinique:

- Souvent précoce, 3 à 5 jrs après l'accouchement
- Signes d'appels :
 - ✗ Fièvre modérée
 - ✗ Douleurs pelviennes peu intenses
 - ✗ Lochies abondantes, louches et malodorantes

- Examen clinique :
 - ✗ Fièvre 38-38,5°C
 - ✗ Palpation: Utérus mal involué, douleur à la mobilisation utérine
 - ✗ Spéculum + TV : Lochies abondantes et malodorantes voire purulentes



❖ **CAT:**

• <u>Hospitalisation</u> • <u>Bilan :</u> ✗ NFS, CRP ✗ <u>Prélèvement bactériologique vaginal</u> ✗ <u>ECBU</u> ✗ <u>Hémoculture si fièvre > 38,5°C</u>	• <u>Traitement:</u> ✗ <u>Antibiothérapie à large spectre adaptée par la suite en fonction de la réponse au traitement et au résultat du Prélèvement vaginal</u> ✗ <u>Utéro-toniques pr favoriser la rétraction utérine</u> ✗ <u>Discuter un traitement anticoagulant préventif</u>
❖ Facteurs favorisants :	❖ Surveillance :
• <u>RPM</u> • <u>Accouchement dystocique</u> • <u>Manœuvres endo-utérines</u> ✗ <u>Délivrance artificielle (DA)</u> ✗ <u>Révision utérine (RU)</u> ✗ <u>VMI</u>	• <u>Température</u> • <u>Hauteur et sensibilité de l'utérus</u> • <u>Aspect des lochies</u> • <u>CRP ++</u>
B. PELVIPÉRITONITES DES SUITES DE COUCHES:	C. THROMBOPHLÉBITES PELVIENNES SUPPURÉES:
• Entre le 7ème et 10ème jour • <u>Fièvre 39°C , pouls accéléré</u> • <u>Altération de l'état général</u> • Examen clinique: ✗ <u>Ballonnement abdominal</u> ✗ <u>Parfois défense sus pubienne</u> ✗ <u>Culs de sac douloureux avec souvent un empatement</u> • Traitement: ✗ Antibiothérapie à large spectre ✗ Si peu ou pas de réponse → chirurgie • Surveillance prolongée	• Syndrome infectieux +++ (teint grisâtre, température oscillante) • Douleur pelvienne unilatéral • Risques : ✗ Extension de thrombose ✗ Localisation infectieuse secondaire • Traitement: ✗ Antibiothérapie ✗ Héparinothérapie
D. INFECTIONS URINAIRES:	
• Signes d'appel : Pollakiurie, brûlures mictionnelles, douleurs lombaires • A l'examen : ✗ Urines troubles, douleurs lombaires ✗ Bandelette urinaire positive (Leucocytes, Nitrites) • L'ECBU confirme le diagnostic	

2. COMPLICATIONS HÉMORRAGIQUES

A. INERTIE UTÉRINE ISOLÉE: • C'est une hémorragie qui apparaît qu'après la période de la délivrance ou succède à une hémorragie de la délivrance maîtrisée • Facteurs favorisants : - Multiparité - Accouchement dystocique - Surdistension utérine (grossesse multiple, macrosomie, hydramnios) - Rupture prématurée des membranes • Début : les premiers jours • A l'examen : - Utérus mou, dépasse l'ombilic - Absence de signe d'endométrite • Échographie: - Vérifie l'absence de rétention placentaire • Principes du traitement :  - Massage utérin - Utérotoniques	B. ENDOMÉTRITE HÉMORRAGIQUE: • 3 à 5 jours après l'accouchement • A l'examen : - fièvre à 38 - 38,5°C - Utérus mal involué , mou - lochies malodorantes - douleurs pelviennes à la mobilisation utérine • PEC : Idem endométrite	C. RETOUR DE COUCHES HÉMORRAGIQUES: • Hémorragie tardive survenant quelques semaines après l'accouchement • L'examen clinique : - Absence de fièvre et de douleurs pelviennes, utérus involué - Pertes non malodorantes - Échographie: Vérifier l'absence de rétention placentaire -Principes du traitement : Estrogènes si pas de contre-indications
--	---	---



3. COMPLICATIONS THROMBOEMBOLIQUES

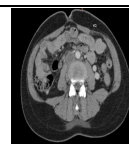
A. PHLÉBITE DES MEMBRES INFÉRIEURS:

- A l'examen bilatéral et comparatif +++:
 - ✗ Au début : œdème discret du membre inférieur (mesure du périmètre de la jambe), chaleur du mollet, douleur provoquée au niveau du mollet à la palpation et à la dorsi-flexion du pied (Homans)
 - ✗ Après : signes inflammatoires avec augmentation de la taille du mollet
- Si suspicion de phlébite : Écho-doppler des membres inférieurs
- Principes thérapeutiques : Héparine et contention veineuse puis relais anti-vitamine K



B. PHLÉBITE PELVIENNE:

- Diagnostic difficile
- Peu faire suite à une endométrite
- Signes non spécifiques:
 - ✗ signes urinaires (dysurie, pollakiurie)
 - ✗ signes intestinaux (ballonnement, ténésme)
 - ✗ Examen clinique : TV: douleur d'un paramètre (cordon induré+/-)
- Echodoppler + Angioscanner
- Principes thérapeutiques :
 - ✗ Héparine
 - ✗ Antibiotiques



4. COMPLICATION PSYCHIATRIQUE: « LA PSYCHOSE PUERPÉRALE »

- Apparaît entre le 5ème et le 25ème jour
- Clinique :
 - ✗ Début souvent par insomnies et angoisse
 - ✗ Puis tableau clinique typique :
 - Bouffées d'angoisse confusionnelles et délirantes
 - Alternance de phases dépressives et d'excitation
- Risque de suicide et/ou d'infanticide
- Nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé
- Si prise en charge précoce → Évolution favorable
- Risque de récurrence pour les grossesses ultérieures

5. COMPLICATIONS DE L'ALLAITEMENT

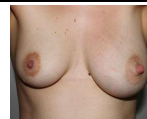
A. CREVASSES:

- Petites érosions, Fissures, Ulcérations du mamelon
- Prévention:
 - ✗ Tétée courte 20 min
 - ✗ Hygiène des mamelons
 - ✗ Topique



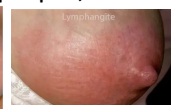
B. ENGORGEMENT MAMMAIRE:

- « Défaut de vidange mammaire »
- Température : 37,8 - 38°
- Seins tendus, Douleurs mammaires uni ou bilatérales
- Traitement :
 - ✗ Vidange mammaire
 - ✗ Au besoin compresse tiède et ocytotique (1/2 ampoule 10 mn avant la tétée)



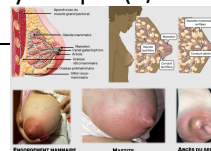
C. LYMPHANGITE AIGUE DU SEIN:

- Début brutal
- Signes d'appel : fièvre élevée à 39 - 40 °C avec frissons et douleurs mammaires unilatérales
- A l'examen :
 - ✗ Placard rouge, chaud, douloureux et adénopathie axillaire douloureuse
 - ✗ Le lait recueilli sur un coton est propre, sans trace de pus
- Traitement:
 - ✗ Cataplasme alcoolisé
 - ✗ Vidange du sein : tire lait ou tétés fréquentes
 - ✗ Si pas d'amélioration au bout de 48 H : Antibiotiques



D. LES ABCÈS DU SEIN:

- ✚ Phase de galactophorite:
 - Début progressif, plusieurs jours
 - Signes d'appel : fièvre modérée à 38 - 38,5 °C et douleurs mammaires unilatérales
 - A l'examen :
 - ✗ Douleurs du sein qui est plus ferme que l'autre
 - ✗ Le lait recueilli sur un coton est mélangé à du pus (signe de Budin++)
 - Traitement: Antibiotiques/Anti-inflammatoires
 - Arrêt de l'allaitement
- ✚ Phase de collection:
 - Douleur pulsatile: T° 39 - 39,5
 - Masse fluctuante
 - Traitement : Drainage /Antibiotiques/Anti-inflammatoires/Arrêt de l'allaitement



VI. CONCLUSION

- Périodes vulnérable
- Examen soigneux et méthodique
- Information des parturientes sur les risques de complication